

도수치료 관리급여 현장 정리본

시행일 2026년 7월 1일

근거 보건복지부 확정고시 제2026-134~137호(2026.6.29 공포), 제10차 건강보험정책심의위원회 의결(2026.6.4), 공식
질의응답(2026.6.29 수정본)

표기 원칙

아래 수치·기준은 모두 공식 고시·보도자료에서 확인한 **확정 사항**입니다. 확인되지 않은 항목은 **[미확인]**으로 표기합니다.

1 한눈 요약

- 도수치료가 **비급여에서 관리급여**(선별급여의 한 형태)로 전환됩니다.
- **수가**: 1일당 43,850원 수준. 전국 모든 요양기관 동일 단가(종별가산 없음).
- **본인부담률**: 95%. 명세서 진료내역 F항(100분의 95)으로 청구.
- **횟수**: 1일 1회, 주 2회 이내, 연 15회 이내 원칙. 의학적 예외 시 연 24회.
- **선행 요건**: 기본물리치료 또는 단순재활치료를 2주 이상·4회 이상 먼저 시행.
- **전산**: 도수치료 관리시스템에 진료정보를 전송해야만 관리급여 인정.

급여 적용 흐름



2 무엇이 바뀌나

- 기존 비급여 「서-122 도수치료[1일당]」가 삭제되고, 목록표 제7편 관리급여목록에 「**관리-1 도수치료[1일당]**」로 신설됩니다.
- 관리급여에는 **종별가산율과 소아·야간·공휴 등 각종 가산을 적용하지 않습니다.**

3 수가 · 본인부담

상대가치점수는 종별로 차등하되, 산출 금액은 **전 종별 1일당 43,850원으로 동일**하게 설계되었습니다(종별가산 미적용).

종별	코드	상대가치점수	요양급여비용	본인부담(95%)
의원	KR006	458.68	43,850원	약 41,660원
병원·종합·상급종합	KR001	523.27	43,850원	약 41,660원
요양·정신병원 내 의과	KR002	520.78	43,850원	약 41,660원
치과병원 내 의과	KR003	433.73	43,850원	약 41,660원
한방병원 내 의과	KR004	420.42	43,850원	약 41,660원
보건의료원 내 의과	KR005	444.73	43,850원	약 41,660원

점수 × 2026 환산지수 ≈ 43,850원으로 전 종별 동일 (보건복지부 2026.6.4 보도자료).

- 본인부담률 95%는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」 별표2의2에 따릅니다.
- **의료급여 1종·2종, 차상위계층도 별도 감면 없이 95%**가 적용됩니다.

4 급여 대상

- 기능이상·통증이 지속되는 **근골격계질환**(요통, 척추관 협착증, 관절 구축 등)에 **30분 이상 실시**한 경우 인정.
- 해당 상병이 **주상병·부상병 모두 적용**됩니다.
- 근골격계질환 외에는 요양급여비용을 산정할 수 없습니다.
- 고시에 **특정 질병코드 목록은 명시되어 있지 않습니다(포괄 규정)**. 개별 인정 여부는 일반기준과 처방의 판단에 따릅니다.

사경 처리 (5·8항 참고)

일반 사경 운동요법은 **사116 복합운동치료**로 산정. 소아 사경에 도수치료를 시행하는 경우는 **선행치료 면제**.

5 선행치료 요건 필수

- 목록표 제7장 이학요법료 **제1절 기본물리치료료** 또는 **제2절 단순재활치료료**를 우선 시행하는 것이 원칙.
- 우선 시행 기간 **최소 2주(14일) 이상, 시행 횟수 4회 이상**이어야 합니다.
- 그럼에도 **호전이 없을 때** 도수치료를 시행한 경우 인정.
- **타 요양기관 시행분도 인정**되며, 타 기관 선행치료 후 내원 당일에도 도수치료 시행 가능.
- 관리급여 적용일(7.1) **이전 시행분도 우선 시행으로 인정**됩니다.
- 수술이 필요한 환자는 수술 전 우선 시행이 이루어졌을 것으로 봅니다.

선행치료 면제

소아의 사경, 또는 수술 후(관절운동범위 제한으로 시행하는 경우 등)에는 의사의 의학적 판단으로 선행치료(2주·4회) 없이 **즉시 도수치료 시행** 가능합니다. (질의응답_수정 2026.6.29, Q21)

6 처방 · 시행 인력 · 치료실 · 장비

- **처방:** 정형외과·신경외과·재활의학과·마취통증의학과 전문의, 또는 보건복지부장관이 정하는 관련 교육을 이수한 의사.
- **시행:** 위 의사 본인, 또는 해당 요양기관 **상근 물리치료사로서 관련 교육을 이수한 자.**
- **1대1, 수기로 30분 이상** 실시한 경우 산정. 1인이 다수 환자에게 동시 적용한 경우는 불인정.
- 의사·물리치료사 1인당 **1일 실시 인원 상한은 없습니다.**

교육 경과 (유예기간)

교육과정은 대한의사협회 등 협의로 신설·운영 예정이며, 이수증 발급단체 지정과 준비기간이 필요하여 **보건복지부 안내 시까지 유예기간**이 있습니다. 안내 이후 4개과 전문의 외의 의사·물리치료사는 보건의료자원 통합신고포털(hurb.or.kr)에서 **교육 이수 여부를 신고**해야 합니다.

- **치료실·장비:** 해당 물리치료를 실시할 수 있는 일정 면적의 치료실과 실제 사용 가능한 장비 보유(고시 바목). 세부 기준은 의료법 시행규칙 별표4 시설규격과 목록표 제7장 이학요법료 물리치료 실시 요건에 따름 (Q28).

7 횡수 규칙

1회

1일 · 환자당
(부위·기관 불문)

2회

주 이내
(월~일 기준)

15회

연간 이내
(1.1~12.31)

24회

의학적 예외 시
(15회 포함)

- **1일 1회만 산정.** 여러 부위 실시해도, 입원·외래 불문, 요양기관 불문 환자당 1일 1회.
- **주 2회 이내.** 주 단위는 월요일~일요일.
- **연간 15회 이내.** 연간은 회계연도(1.1~12.31). **2026년은 7.1~12.31까지 15회** 산정 가능.

의학적 예외 (연 24회)

수술·골절 등으로 인한 **관절의 구축·강직의 뚜렷한 소견**이 있으면 의사 판단으로 **연간 총 24회(15회 포함)**까지 인정. 수술·골절 병력이 없어도 **퇴행성관절염·오십견 등으로 구축·강직 소견**이 있으면 추가 9회(총 24회)까지 가능.

- **예외 적용 절차:** 15회 초과 시점에 예외사유를 판단하여 시스템에서 **예외사유 Y를 선택해 제출**하면 별도 절차 없이 인정. 단, 치료효과 평가 등을 **진료기록부에 반드시 작성·보존.**
- 자격(건강보험·의료급여·보훈) 변경 시에도 **연 15회(예외 24회) 한도는 합산·공유**되며 잔여 횡수만 적용.

8 동시 산정 규칙

항목	동시 산정 여부
마사지치료 (사105)	도수치료 소정점수에 포함되어 별도 산정 불가
운동치료(사106·사116)·재활기능치료(사130)	같은 날 실시 시 주된 항목의 소정점수만 산정
국소주사 등 (관절강내·신경간내주사·신경차단술)	의학적 판단으로 인정기준 부합 시 동시 산정 가능
비급여 물리치료 (체외충격파·신장분사 등)	별도 제한 없으나 학회 가이드라인 준수 권고, 동시 시술 모니터링 예정

참고: 사경(Torticollis) 처리

사경에 실시한 운동요법은 도수치료가 아니라 **사116 복합운동치료[1일당]**로 산정합니다(고시 제2007-46호). 사116은 일반 급여 행위로 본인부담률·산정방식이 도수치료 관리급여(95%)와 다르며, **1일 1회·횟수 불문**으로 1일당 소정점수 산정. 6.29 확정고시 4건은 사경·사116 규정을 변경하지 않았습니다.

사116-가 복합운동치료[1일당] 소정점수 105.21점 (코드 MM102)

종별	요양급여비용(환산지수 적용)	외래 본인부담률	외래 본인부담 예시
의원	약 10,060원 (95.6원)	30%	약 3,020원
병원	약 8,820원 (83.8원)	40%	약 3,530원
종합병원	약 8,820원	50%	
상급종합	약 8,820원	60%	
치과	약 10,640원 (101.1원)		
한방	약 10,970원 (104.3원)		

입원 본인부담 20%. 요양·정신병원 내 의과 약 8,860원(84.2원).

사116 적용대상: 가) 중추·말초신경 또는 근육 손상 후 신경근 재교육, 나) 긴장성 근육통·요통·경부통 등 만성 통증, 다) 자발성 운동장애 (강직성 사경·안면연축·파킨슨 증후군 등). 등속성운동기구를 제외한 기계·기구로 근력강화운동·기능훈련 30분 이상 실시 시 산정.

9 청구 방법

- 제7편 관리급여목록 행위는 **선별급여 95%를 적용해 명세서 진료내역 F항(100분의 95 본인부담)**으로 청구.
- 그 밖의 청구 방식은 다른 이학요법료와 동일.
- 15회 초과로 예외사유 Y 적용 시 **청구명세서 특정내역에 별도 기재 불필요**. 단, 진료기록(시행자·기법·부위·소요시간·치료효과 평가 등) 작성·보존은 필수.

10 도수치료 관리시스템 필수 운영

환자당 연간 실시횟수(타 의료기관 포함)를 조회·관리하고, 진료정보를 심평원에 전송하는 시스템입니다. API 기반 EMR 연계와 웹포털(ef.hira.or.kr) 제출이 모두 가능합니다.

핵심 원칙

진료정보가 시스템에 전송되어 있는 경우에만 관리급여가 적용됩니다. **전송하지 못하면 요양급여비용으로 산정할 수 없습니다.**

- **전송 시점:** 시행 시점 전송이 원칙, 늦어도 환자가 머무는 동안 전송. 전송 주체는 진료 담당 인력(의사·물리치료사)이 원칙이나 운영상황에 맞게 조정 가능.
- **선전송 우선:** 다른 기관이 동일 회차(주 2회 초과분, 24회째)를 먼저 전송하면 **이후 기관은 전송·인정 불가**. 반드시 시행 시점에 전송.
- **타 기관 횟수 조회:** 타 의료기관 실시 횟수 포함 조회 가능, 우리 병원 여부 표시. **의료기관명은 제공되지 않음.**
- **예약 건:** 미래 날짜로는 등록 불가. 실제 진료일 당일 또는 그 전에 기실시 횟수 조회 후 시행 일자로 등록.
- **삭제 기한:** 월~목 진료건은 해당 주 금요일 18시 이전, 금·토·일 진료건은 당일 삭제 가능. 기한 이후는 심평원 급여전략부(033-739-0313)에 요청.
- **자격 적용:** 제출 대상은 건강보험·의료급여·보훈. **자동차보험·산재보험·건강보험 무자격자는 제출 대상 아님.**
- **로그인:** 상용 SW 인증서 또는 건보공단 공동인증서를 심평원 홈페이지 등록 후 사용. 전송 오류 시 재전송.
- **신포괄 시범사업 기관도** 요양급여 대상 도수치료 실시 시 관리시스템 제출 의무.

11 진료기록 의무

- 처방한 자, 시행자, 시행 기법, 시행 부위, 소요시간, 치료효과 평가 등을 포함하는 기록을 **작성·보존**해야 합니다.

12 비급여 가능한 경우 / 초과분

초과분 비급여 전환 불가

질환 치료 목적 도수치료는 **연 인정 횟수를 넘겨 받을 수 없고, 초과분을 비급여로 전환해 청구하는 것도 불가**합니다.

- 질환 치료 목적이 **아닌 경우**(피로 회복·체형 교정 등 개인적 필요)는 전액 본인부담(비급여)으로 가능. 이 경우 **건강보험·실손보험 적용 안 됨.**

13 평가주기

- 관리급여는 **3년 주기로 재평가**하며, 재평가 시 급여 유형·전환 원칙 등 세부기준이 추가 마련될 예정입니다.

14 자동차보험 · 산재보험 적용

자동차보험 (교통사고 환자)

- 건강보험과 동일 수가(1회 43,850원)·급여기준 적용.
- **차이점:** 인정회수는 건강보험의 '연간 총 횟수'가 아니라 **치료기간 중 총 횟수**로 적용.
- 시행: 2026.7.1 진료분부터.
- **관리시스템 제출 대상 아님**(제출은 건강보험·의료급여·보훈만). 수가·급여기준만 건강보험과 동일 적용.

근거: 국토교통부 고시 제2025-369호, 국토교통부 알림(자동차운영보험과-6510, 2026.6.29).

산재보험 (근로복지공단) **확정**

2026.7.1 진료분부터 산재보험 도수치료도 **건강보험 관리급여 기준을 그대로 적용**합니다(산재보험 요양급여 산정기준 제4조제3항).

구분	변경 전	변경 후 (2026.7.1~)
단가	68,000원	43,850원 (건강보험 동일)
수가코드	51040 단일	KR001~KR006 (종별)
횟수	주 3회·치료기간 중 15회	주 2회·연 15회 (예외 24회)
선행치료	해당 없음	2주·4회 요건 동일 적용
본인부담	해당 없음	없음 (산재보험 전액 부담)
인력	의사 지도·감독하 물리치료사	교육 이수 의사·물리치료사

- **개정일 이전(2026.1.1~6.30) 실시분도 연간 횟수에 합산.**
- **청구:** 진료비명세서 항목번호 0601(관리급여 이학요법료), 산정코드 KR001~006. 연 15회 초과 시 특정내역 기타내역(구분코드 JX999)에 사유 기재(미기재 시 자동조정).
- 산재 도수치료관리 전산(조회) 시스템 구축 전까지는 **고용·산재보험 토털서비스**로 누적 횟수(타 의료기관 합산) 확인.

근거: 근로복지공단 「(의료기관 안내용) 도수치료 산재보험 업무처리 방법 안내」 (2026.6.29), 산재보험 요양급여 산정기준 제4조제3항·별표2.

15 현장 혼선 포인트 점검

체크 1. 즉시 시행 불가

7.1부터 환자가 내원 즉시 도수치료를 받을 수 없습니다. **선행치료 2주·4회 기록을 먼저 확인**(타 기관·7.1 이전분도 인정). 단, **소아 사경·수술 후 관절운동범위 제한 등은 면제로 즉시 시행 가능**.

체크 2. 미전송은 산정 불가

도수치료 관리시스템 미전송은 산정 불가입니다. **시행 시점 전송을 습관화**하세요.

체크 3. 상병코드 모호 시

개별 질환의 급여 인정 여부가 모호하면(상병코드 목록이 고시에 없음) **처방의 판단과 심평원 안내를 확인**합니다.

체크 4. 교육 이수 신고

교육 이수 신고는 **보건복지부 안내가 나온 이후 유예기간 종료 시점**에 맞춰 진행합니다.

16 근거 · 출처 (공식)

- 보건복지부 고시 제2026-134·135·136·137호(2026.6.29 공포, 2026.7.1 시행). 보건복지부 누리집 알림 > 법령 > 고시.
- 보건복지부 보도자료 「도수치료 회당 4만 원대 수가 적용, 주 2회, 연간 최대 24회로 제한」(2026.6.4, list_no=1490729).
- 도수치료 관리급여 기준 질의응답_수정(심평원 공지, 2026.6.29, brdBltno=12133). 6.19 행정예고 별첨 질의응답을 대체하는 최신본.
- 도수치료 관리시스템: 심평원 요양기관 업무포털 ef.hira.or.kr.
- 국토교통부 고시 제2025-369호 「자동차보험진료수가에 관한 기준」(2025.6.30) 및 국토교통부 알림(2026.6.29).
- 근로복지공단 「도수치료 산재보험 업무처리 방법 안내」(2026.6.29), 산재보험 요양급여 산정기준 제4조제3항·별표2.

관련 문서

관리시스템 화면 사용법(접속·등록·입력항목·횟수보기·조회·삭제)은 별도 문서 「현장정리본_도수치료_관리시스템_사용안내」 참고. 환자 안내용은 「현장정리본_도수치료_환자용」 참고.